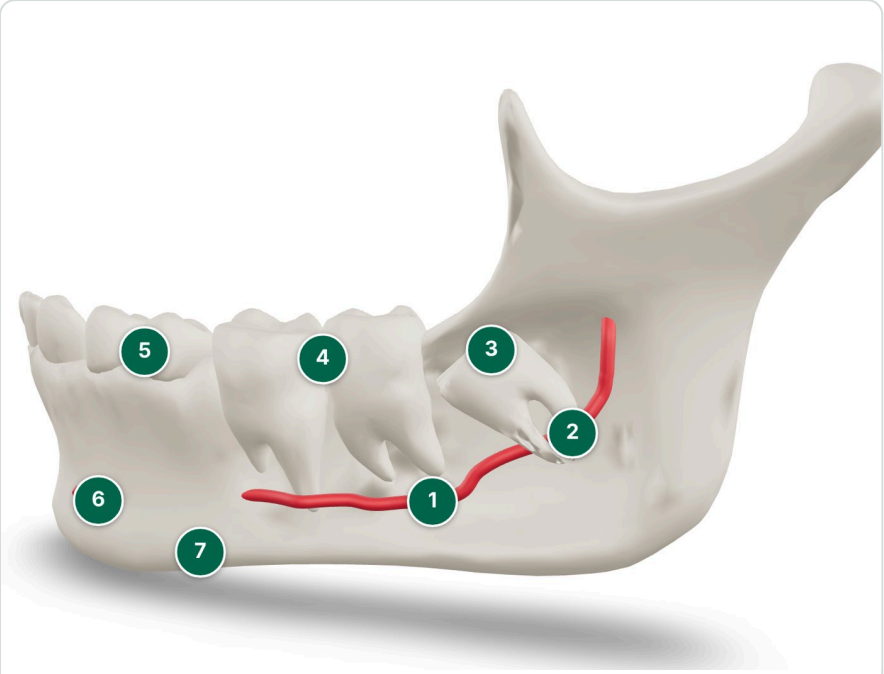
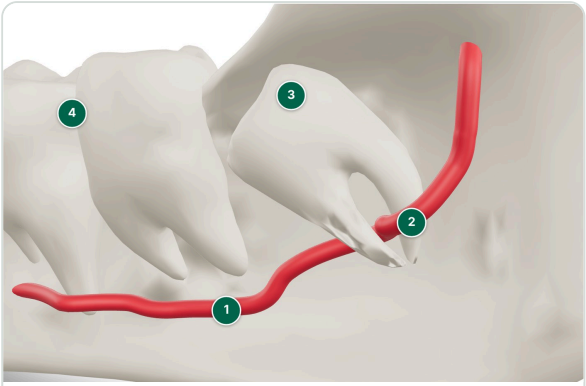
うまっている下の親知らずと、そのそばを通る神経

この親知らずの根は、神経に巻き付いています。歯をぬくと、神経が傷つき、くちびるやあごがしびれることがあります。



全体（ほお側）

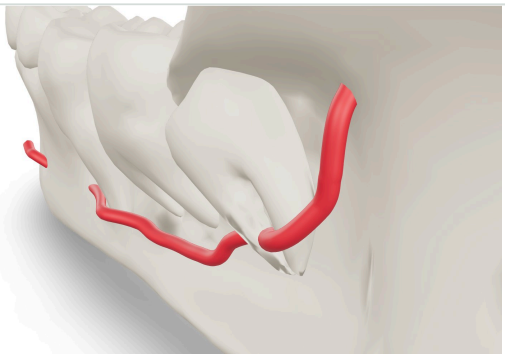


根と神経（拡大）

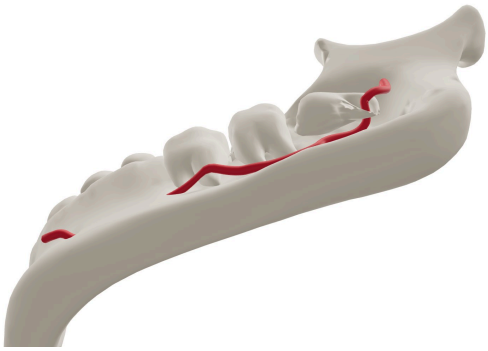
あごの骨と歯　神経・動脈・静脈（下あごの管の中）

モデルの各部分

1. 下あごの神経（かしそう神経）
2. 親知らずの根
3. 親知らず（第三大きゅう歯）
4. 第一・第二大きゅう歯
5. 第一・第二小きゅう歯
6. あごの先の神経（おとがい神経）
7. 下あごの骨



後ろから見た根と神経



下から見た、骨の中の神経

どんな状態ですか？

親知らずは、いちばんおくにある歯です。「**第三大きゅう歯**」ともよびます。**うまっている下の親知らず**は、歯ぐきと骨の下にあり、歯ぐきの上に出ていません。正しい向きに生えることができません。

神経について

下あごの骨の中には、細い管があり、その中を神経が通っています。ここでは「**下あごの神経**」とよびます。医学での名前は「**かしそう神経**」です。同じ管の中を、2本の血管（**かしそう動脈**と**かしそう静脈**）もいっしょに通っています。[1]

下あごの神経は、同じ側の下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[2] あごの前の方で、この神経の枝が、骨の小さなあなから外に出ます。この枝を「**おとがい神経**」とよびます。下くちびるとあごの感覚を伝えています。[3]

舌の感覚は、別の神経（**舌神経**）が伝えています。舌神経も、親知らずをぬくときに傷つくことがあります。[4] 舌神経の傷がずっと続くことはまれで、1000人に1〜3人ほどです。[5] このモデルでは、舌神経は表していません。

このモデルでは、**親知らずの根が、神経と動脈に巻き付いています**。

歯をぬくと、なぜ神経が傷つくことがあるのですか？

歯をぬくには、根を骨から取り出す必要があります。根は、神経を囲むように曲がっています。そのため、根を取り出すときに、神経がおされたり、のびたり、切れたりすることがあります。いっしょに通る動脈や静脈が傷ついて、血が出ることもあります。[1]

下あごの神経が傷つくと、その枝のおとがい神経もうまく働かなくなることがあります。[3]

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下くちびる、あご、歯、歯ぐきに、次のようなことが起こります。[2,4]

- しびれる
- ピリピリする
- いつもとちがう感じがする
- いたむ

一時的な場合：感覚はもどります。多くは、数週間から数か月かかります。**ずっと続く場合：**感覚が完全にはもどりません。[2]

年れいが高い人ほど、神経が傷つきやすく、感覚も完全にはもどりにくくなります。[2,6]

どのくらい起こりますか？

根が神経に近い親知らずについて、16の研究をまとめた報告があります。報告によって差がありますが、次のようになります。[7]

100人中 約7人
歯を全部ぬいた後に、神経が傷つくかもしれない

100人中 約1人
神経の傷が治らないかもしれない

参考にした論文 **0.** Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e2. doi.org/10.5037/jomr.2010.1102 **0.** Sarikov R, Juodzbalys G. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401 **0.** Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e3. doi.org/10.5037/jomr.2010.1103 **0.** Renton T, Yilmaz Z. J Orofac Pain. 2011;25(4):333-344. PMID 22247929. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22247929 **0.** Lee J, Feng B, Park JS, et al. PLoS One. 2023;18(2):e0282185. doi.org/10.1371/journal.pone.0282185 **0.** Queral-Godoy E, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(3):259-264. doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.06.001 **0.** Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459

この資料は、名古屋大学の研究のためのものです。第2.2版（2026年10月21日）。